

10 - 04- Insuffisance aortique - Pr. El Karimi

Bonjour chers étudiants, Le cours d'aujourd'hui s'intitule l'insuffisance aortique. Une pathologie fréquente dans notre contexte peut être grave dans les formes évoluées et c'est une pathologie caractérisée par la richesse de ses étiologies et la richesse de ses signes symptomatiques cliniques. Au terme de ce cours, nous devons être capables de définir l'insuffisance aortique, d'expliquer les mécanismes de survenue de cette pathologie ainsi que ses conséquences, d'énumérer ses étiologies, d'identifier les caractéristiques des signes fonctionnels et physiques en faveur d'une insuffisance aortique chez un patient se présentant pour une dyspnée.

Nous devons être capables aussi de citer les résultats des examens paracliniques demandés chez un patient suivi pour cette pathologie ainsi que d'énumérer les complications pouvant survenir chez ces patients. Enfin, nous devons être capables de citer les traitements curatifs pouvant être indiqués chez cette population et de prescrire le protocole de prévention de l'endocardite infectieuse chez ces patients. Pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant.

D'abord, une introduction. Après, nous allons voir un rappel anatomique et physiologique avant de s'étaler sur la physiopathologie. Ensuite, nous allons voir les étiologies de l'insuffisance aortique, dont ses formes aiguës et chroniques.

Après, nous allons s'étaler sur le diagnostic positif, évolutions et complications. Nous allons voir d'une manière succincte les formes cliniques. Après, nous allons détailler le traitement avant de conclure.

C'est quoi une insuffisance aortique? C'est la perte d'étanchéité de la valve aortique. On sait que la valve aortique doit se fermer en diastole pour empêcher le reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche, ainsi que pour favoriser le remplissage du ventricule gauche au moment de la diastole. Quand cette valve perd son étanchéité, elle ne va pas se fermer complètement au moment de la diastole, ce qui va favoriser le reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche lors de la diastole.

C'est une pathologie fréquente. Ses conséquences peuvent aussi être graves en l'absence d'un traitement précoce et codifié. Dans notre contexte, le rhumatisme articulaire aigu constitué la cause la plus fréquente et on souligne l'intérêt de la prévention qui va nous permettre d'éviter l'évolution vers ces complications.

Sur le plan anatomique et physiologique, le cœur est constitué de deux côtés, le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche est constitué de l'oreillette gauche et du ventricule gauche et le côté droit de l'oreillette droite et du ventricule droit. L'oreillette gauche et le ventricule gauche sont séparés par la valve mitrale et le ventricule gauche donne issue à l'aorte qui va assurer l'éjection vers la périphérie.

Du côté droit, nous avons l'oreillette droite qui sépare le ventricule droit par la valve tricuspide. Le ventricule droit assure l'éjection du sang vers la circulation pulmonaire à travers l'artère pulmonaire. Un petit rappel sur l'anatomie de la valve aortique.

La valve aortique est constituée de trois feuillets appelés les sigmoïdes. Ces trois sigmoïdes donnent issue à l'aorte. Ces trois sigmoïdes sont accolés à l'aorte par ce qu'on appelle les sinus.

Ainsi, on trouve la sigmoïde non coronaire et les postérieurs et les sigmoïdes antérieurs, droite et gauche appelés aussi les sigmoïdes coronaire droite et sigmoïdes coronaire gauche parce qu'au niveau de leur sinus sort l'artère coronaire droite ou l'artère coronaire gauche. Pour pouvoir comprendre la physiopathologie, un petit rappel sur la physiologie, le cycle cardiaque est nécessaire. Le son veineux oxygéné qui vient du poumon va rejoindre l'oreillette gauche puis le ventricule gauche à travers la valve mitrale.

Après, il va rejoindre la circulation systémique à partir de l'aorte. A partir de l'aorte, le son oxygéné va rejoindre les différents organes comme le cerveau, les muscles, le reins, où ce son va être pris par ces organes et avec libération du CO₂. Le son désoxygéné, libéré à partir de ces organes, va rejoindre le coeur à travers la veine inférieure et supérieure.

Ainsi, il va rejoindre les poumons à travers l'artère pulmonaire. Nous allons voir maintenant la physiopathologie de l'insuffisance aortique. Dans cette physiopathologie, nous allons voir le mécanisme et les conséquences.

En ce qui concerne les mécanismes, plusieurs mécanismes peuvent intervenir pour modifier la structure de la valve aortique. Il peut s'agir d'une rétraction valvulaire, d'un prolapsus, d'une dilatation de l'anneau ou bien d'une perforation de la valve. En ce qui concerne les conséquences, il faut savoir qu'ils sont variables en fonction de l'insuffisance aortique modérée ou bien d'une insuffisance aortique sévère.

Dans l'insuffisance aortique modérée, en général, il n'y a pas de conséquences hémodynamiques mais il y a un risque d'endocardite infectieuse. Comme on le dit toujours, le risque d'endocardite infectieuse n'est pas lié à la sévérité de la valvulopathie. Par contre, dans les formes sévères, les conséquences hémodynamiques changent en fonction qu'il s'agit d'une insuffisance aortique aiguë ou d'une insuffisance aortique chronique.

Dans l'insuffisance aortique chronique, l'évolution se fait sur plusieurs mois voire années. Donc il s'agit, comme on l'a dit dans l'introduction, d'un passage du sang de l'aorte vers le ventricule gauche au moment de la diastole. Ceci va avoir des conséquences en amont et qui dit en amont, donc toutes les structures qui sont en amont de la valve aortique.

Donc il peut s'agir du ventricule gauche, du poumon, voire le coeur droit. En ce qui concerne les conséquences en aval, comme on va le voir plus tard, il peut s'agir de conséquences sur la circulation systémique et sur la circulation coronaire. Quand vous le voyez sur ce dessin, nous

avons des retentissements en aval de la valve aortique et des retentissements en amont.

En ce qui concerne les retentissements en amont de la valve aortique, ils sont entourés du cadran rouge et on trouve un retentissement sur le ventricule gauche, l'oreillette gauche, les veines et capillaires pulmonaires, les poumons, c'est-à-dire le milieu interstitiel et le milieu alvéolaire, après les artères et les artérioles pulmonaires et enfin les cavités droites. Pour le retentissement en aval, encadré par le trait vert, il va concerner la circulation systémique avec les organes périphériques et la circulation coronaire. En ce qui concerne les conséquences en amont, on va commencer par celle du ventricule gauche.

En effet, cette cavité est exposée à deux types de phénomènes, le premier se déroule en diastole, le deuxième en systole. En moment de la diastole, le ventricule gauche est exposé à une surcharge volumétrique ou surcharge de volume. Pourquoi ? Parce que cette cavité reçoit à la fois le sang normal qui provient de l'oreillette gauche en moment de la diastole, mais elle reçoit aussi le sang reflué de la horte vers le ventricule gauche.

Donc pour supporter cette surcharge de volume, le ventricule gauche doit s'adapter et donc il va se dilater progressivement. Cette dilatation progressive va aboutir à la fin à une altération de sa fonction. De l'autre côté, en systole, le ventricule gauche doit éjecter une grande quantité du sang à laquelle il n'est pas habitué.

Donc l'exemple type c'est comme si on vous demande à 10 étudiants de quitter la salle à partir d'une porte. Pour 10 étudiants, la sortie va être facile. Le jour où je vais demander à 50 étudiants de quitter la salle avec la même vitesse et à partir de cette porte.

Cette porte va se comporter comme un obstacle, même si sa taille normale. Donc il va se comporter comme un obstacle fonctionnel parce qu'il était exposé à une surcharge, à un travail de plus. La même chose se passe au niveau de ses sigmoïdes aortiques.

A cause de cette surcharge de volume qui doit passer à travers un orifice qui est fixe qui va se comporter comme une sténose. Donc le ventricule gauche est exposé à une surcharge de pression. Donc il va s'hypertrophier progressivement.

Cette hypertrophie progressive va aboutir à la fin à une altération progressive de la fonction ventriculaire gauche. Pour récapituler, dans l'insuffisance aortique, le ventricule gauche est à la fois dilaté et hypertrophié. Ce qui se passe maintenant au niveau de l'oreillette gauche, veine pulmonaire, capillaire pulmonaire sont à peu près identiques à ceux qu'on a vu dans le cours de l'insuffisance mitrale.

C'est-à-dire qu'on peut assister à une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche qui va être responsable de la dilatation de cette dernière avec risque de fibrillation auriculaire, thrombose, lequel va être responsable d'embolies systémiques. On peut assister également à l'augmentation de la pression au niveau des veines pulmonaires avec hypertension

pulmonaire post-capillaire. L'augmentation de la pression au niveau des capillaires pulmonaires qui va dépasser la pression oncotique va être responsable du passage du liquide vers le milieu interstitiel avec apparition de signes d'insuffisance cardiaque gauche.

Mais il faut noter que la dilatation de l'oreillette gauche est généralement moins importante par rapport à celle de l'insuffisance mitrale. Donc on a moins de risque de fibrillation auriculaire et moins de risque de thrombose. Et le tableau typique qu'on voit d'une manière générale, c'est celui d'une insuffisance cardiaque gauche.

Il en est de même pour les retentissements sur les artères et les artéioles pulmonaires ainsi que les cavités droites. Ils peuvent être identiques à celles de l'insuffisance mitrale, mais en général ils sont plus rares par rapport à l'insuffisance mitrale et leur présence traduit l'arrivée à un stade très avancé de la maladie. Nous allons voir maintenant les conséquences en aval et comme on l'a vu dans l'introduction, ça va concerner la circulation coronaire et systémique.

En ce qui concerne la circulation coronaire, on sait que la perfusion des artères coronaires et bien sûr le muscle myocardique se fait en diastole. Or, on a une insuffisance aortique avec un reflux du son de l'aorte vers le VG au moment de la diastole. Donc, on va assister à une hypoperfusion des artères coronaires, ce qui va favoriser l'ischémie myocardique, aggraver la dysfonction ventriculaire gauche qui va être responsable de l'aggravation des signes d'insuffisance cardiaque gauche et un stade avancé à une diminution du débit cardiaque qui va se traduire par un retard staturo-pondéral, un amaigrissement, voire des signes de bas débit.

En ce qui concerne la circulation systémique, on va assister au tout début à une augmentation du volume d'éjection systolique. Pourquoi ? Parce que ce volume va contenir le son qui provient de l'oreillette gauche et celui qui a reflué de l'aorte. Donc, on aura une hyperpulsatilité des vaisseaux du cou avec tous les autres signes périphériques de l'insuffisance aortique qu'on va voir.

On aura également un élargissement de la différentielle. C'est quoi l'élargissement de la différentielle ? C'est-à-dire qu'on aura tendance à avoir une pression artérielle systolique qui est normale ou bien un peu élevée à cause du volume d'éjection qui est élevé et une pression artérielle diastolique qui est basse à cause du reflux du son qui s'est fait vers le ventricule gauche. Donc, on aura un élargissement on appelle de la différentielle comme je l'ai dit à cause d'une pression artérielle systolique qui est normale ou normale haute ou bien avec plutôt une pression artérielle diastolique qui est basse.

À un stade avancé, la diminution du débit au niveau de la circulation systémique à cause de ce reflux du son vers le ventricule gauche va participer à son tour à la diminution du débit cardiaque avec retard staturopondéral, amaigrissement et bas débit comme on l'a vu tout à l'heure. On a vu l'insuffisance aortique chronique, maintenant on va passer à la forme aiguë et comme on l'a dit tout à l'heure le mode d'installation est brutal et le cœur n'a pas le temps de s'adapter. Donc, la même chose dans l'insuffisance aortique aiguë, on aura des retentissements en amont et des

retentissements en aval.

Pour celui d'un avant, le ventricule gauche n'a pas le temps de s'adapter, c'est à dire de se dilater et ceci pour amortir l'augmentation du volume. Donc, cette surcharge elle va être rapidement transmise vers les poumons ce qui va favoriser la survenue de l'œdème aigu du poumon. Donc, le VG ne se dilate pas, l'oreillette gauche non plus n'a pas le temps de se dilater pour assumer cette surcharge de volume.

Donc, cette surcharge va être transmise directement vers les poumons et du moment qu'il y a la soupape via le milieu interstitiel et alvéolaire donc le liquide va passer vers le milieu alvéolaire et on aura un œdème aigu des poumons. De l'autre côté et en aval, on aura une baisse de la perfusion coronaire ce qui va favoriser l'ischémie myocardique avec la diminution du débit cardiaque ce qui va favoriser le choc cardiogénique. Cette ischémie myocardique va être responsable aussi de l'œdème aigu des poumons.

Donc, dans l'insuffisance aortique aiguë, la dilatation du VG est absente pas de dilatation de l'oreillette gauche ni de cavité droite. On arrive maintenant aux étiologies de l'insuffisance aortique. Dans sa forme chronique, on note plusieurs étiologies dans la tête du fil il y a la cause rhumatismale dystrophique notamment le syndrome de Marfan on trouve aussi la cause dégénérative qui se voit chez les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire notamment l'hypertension artérielle l'athérosclérose et l'insuffisance rénale chronique.

Enfin, on trouve la cause congénitale les aortiques, notamment la syphilis puis les causes rhumatologiques et les maladies de système. Ce que je vous demande de retenir c'est ce qui est cité en rouge c'est à dire rhumatismale dystrophique avec le syndrome de Marfan dégénérative avec l'HDA, athérosclérose et insuffisance rénale et enfin la cause congénitale. En ce qui concerne l'insuffisance aortique aiguë, les étiologies peuvent être limitées en nombre de trois l'endocardite infectieuse la dissection de l'aorte aiguë et la cause rhumatique.

Comment faire maintenant le diagnostic de l'insuffisance aortique ? D'abord les circonstances de découverte, en général il est fortuit. Il faut savoir que l'insuffisance aortique c'est une maladie qui évolue dans le temps et reste longtemps symptomatique. Donc l'apparition de symptômes ne survient que dans les formes avancées.

Donc il ne faut pas attendre les symptômes pour faire le diagnostic car il y a une notion de latence complète pendant plusieurs années. Donc la découverte se fait soit d'une manière fortuite lors d'un examen systématique ou bien lors d'un suivi d'un patient ayant un antécédent de rhumatisme articulaire aiguë, de maladie de système, d'athérosclérose ou bien qu'il a un syndrome marfanôïde, etc. Donc c'est l'exemple de consultation un patient qui veut passer un concours pour intégrer le système militaire ou la police et on lui a demandé par exemple un certificat ou bien une attestation médicale, c'est à dire un exemple de découverte fortuite d'une insuffisance aortique.

Donc l'interrogatoire dans une première étape doit s'assurer de la présence de symptômes ou non parce que le malade peut-être aussi symptomatique ou bien peut limiter son activité d'une manière inconsciente et se dire asymptomé. Deuxième étape, il faut détailler le symptôme et les signes associés. D'après la physiopathologie, on comprend bien que la dyspnée constitue le maître symptôme mais on peut avoir d'autres signes, sémiologiques comme la lipothémie, l'engor d'effort, on a vu dans la physiopathologie pourquoi on aura de l'engor d'effort à cause de l'hypoperfusion coronaire, on peut avoir des palpitations à cause de la dilatation de l'oreillette gauche qui est responsable de fibrillation auriculaire et de moins en moins, on peut voir des signes droits comme oedème des membres inférieurs et pathologies d'effort et comme on l'a dit dans le chapitre de la physiopathologie, les signes droits ou l'évolution vers l'insuffisance cardiaque droite restent moins fréquentes par rapport à l'insuffisance mitrale.

En troisième étape, il faut chercher les antécédents qui vont orienter vers l'étiologie de cette insuffisance aortique, notamment la notion du rhumatisme articulaire aigu, est-ce que le patient a eu des antécédents d'arthrite ou d'arthralgie dans l'enfant, ce qui sont mal traités, notion d'angina répétition, est-ce qu'il est suivi pour une maladie de système, d'une maladie rhumatologique, hypertension artérielle, maladie athérosclérose. Après l'interrogatoire, on passe à l'examen physique et bien sûr, on commence par l'inspection qui peut montrer un choc de pointe qui peut être vraiment visible et très visible. On peut trouver aussi une déformation thoracique et surtout chez l'enfant.

Je rappelle que la déformation thoracique peut être associée à la malformation cardiaque quand on est dans une ambiance de cardiopathie congénitale, donc on a à la fois la malformation cardiaque et thoracique, comme elle peut être conséquence de l'atteinte cardiaque, parce que l'enfant a une structure cartilagineuse, donc avec la dilatation des cavités ventriculaires, ça retentit sur la protrusion du thorax. La palpation va montrer un choc apexien qui est violent, étalé, dévié en bas et à gauche. On l'appelle choc en dents de parde.

C'est un choc comme je viens de le dire, un choc qui est très très violent. On peut trouver également un frémissement diastolique au niveau du foyer aortique quand l'insuffisance aortique est significative. L'auscultation aortique va mettre en évidence le souffle en rapport avec cette insuffisance aortique dont il faut préciser les caractéristiques.

Le siège, c'est le deuxième espace intercostale droit. Le temps, c'est un souffle qui est diastolique, il a une forme triangulaire, c'est à dire qu'il est intense en B2 et puis il diminue progressivement. Son timbre est doux, aspiratif.

Il irradie le long du bord gauche du sternum et parfois même la pointe du coeur et il est mieux perçu en position penchée en avant et en expiration forcée. Certains éléments sont associés à ce souffle comme le souffle systolique éjectionnel d'accompagnement. Pourquoi ce souffle systolique ? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure dans le chapitre Physiopathologie, le ventricule gauche doit éjecter à travers l'aorte une grande quantité du sang, une surcharge

volumétrique et ceci pour une orifice aortique qui est fixe.

Donc ça se comporte comme un rétrécissement aortique, mais il est fonctionnel. Ce n'est pas parce que la valve est malade, c'est parce qu'on lui a demandé de faire sortir une grande quantité du sang. Et ce n'est pas parce qu'il y a un rétrécissement aortique réel.

Donc on l'appelle souffle systolique éjectionnel d'accompagnement. On peut trouver également un roulement apexien, c'est-à-dire au niveau de la pointe du coeur, appelé roulement apexien de Flint. Donc je vous laisse apprécier le souffle en cliquant sur le bas.

L'insuffisance aortique est associée à d'autres signes, appelés les signes périphériques, qui ont une sémilogie très riche. Parmi ces signes périphériques, on va noter des signes en rapport avec l'hyperpulsatilité artérielle, notamment la danse des carotides au niveau des vaisseaux du cou. Le signe de Musset, c'est une secousse de la tête et qui est concordante avec l'ébattement du coeur.

Ce signe de Musset est lié à Alfred Musset, un écrivain français, qui a découvert ce souffle chez lui et qui était suivi pour une insuffisance aortique d'origine syphilitique. On note aussi la présence des poux qui sont très amples et bondissants. Enfin, on trouve le signe de la manchette qui se traduit par une hyperpulsatilité au niveau de l'avant-bras et qui est mieux appréciée à la palpation.

Aussi, on trouve au niveau du triangle de Scarpa un double souffle, crural de Durosier. Il s'agit de l'auscultation d'un souffle diastolique très audible quand on exerce une pression très forte par le pavillon du stéthoscope. À côté des signes qui sont en rapport avec l'hyperpulsatilité artérielle, on note aussi l'élargissement de la pression artérielle différentielle avec baisse de la pression artérielle diastolique, comme on l'a bien expliqué lors de la physiopathologie.

Regardez sur cette vidéo c'est la danse des carotides donc l'hyperpulsatilité des vaisseaux du cou, une forme assez historique. Le signe de MuC regardez le sujet normal et quand on a un signe de MuC positif. Sur cette photo vous trouvez le signe de la manchette et puis la dernière photo, le double souffle crural du rosier qu'on peut mettre en évidence lors de la palpation de l'artère fémorale au niveau du triangle de Scarborough.

Autres signes d'examen peuvent être mis en évidence notamment les signes d'insuffisance cardiaque gauche, les signes d'hypertension artérielle pulmonaire et d'insuffisance cardiaque droite et comme on l'a dit ces deux derniers sont en général moins fréquents par rapport à l'insuffisance mitrale et leur présence traduit à un stade avancé de la maladie. On arrive maintenant aux examens paracliniques on va commencer par l'électrocardiogramme qui va montrer des signes en rapport avec l'hypertrophie ventriculaire gauche avec une surcharge diastolique. On peut trouver également des signes en rapport avec l'hypertrophie auriculaire gauche et parfois un bloc de branche gauche complet.

La radiographie thoracique quant à elle, elle va montrer un arc supérieur gauche qui est déroulé en rapport avec la dilatation de la horte. On peut trouver également un arc inférieur gauche allongé avec une pointe sous-diaphragmatique en rapport avec la dilatation du ventricule gauche. L'échographie comme on l'a dit plusieurs fois dans les cours précédents elle va montrer des signes en rapport avec le diagnostic positif de l'insuffisance aortique le mécanisme en étudiant la morphologie de la valve aortique elle va nous donner des informations sur la sévérité de cette fuite le retentissement, notamment la dilatation et la fonction ventriculaire gauche la dilatation de la horte dilatation de l'oreillette gauche les signes d'hypertension pulmonaire ainsi que les signes en rapport avec la dilatation et l'étude de la fonction des cavités droites elle peut montrer aussi des signes en rapport avec des lésions associées comme d'autres atteintes valvulaires des signes en rapport avec une cardiopathie congénitale etc.

C'est des photos qui montrent quelques images qu'on peut trouver à l'échocardiographie On arrive maintenant au cathétérisme cardiaque qui est rarement nécessaire on peut demander un cathétérisme droit quand on a un doute sur des pressions pulmonaires très élevées parfois pour quantifier l'insuffisance aortique quand elle est difficile à évaluer à l'échocardiographie chose qui reste relativement rare et on peut lui demander également pour faire une coronarographie dans l'objectif de voir les artères coronaires qui est systématiquement chez tout homme supérieur à 40 ans et chez la femme même opposée avant l'indication opératoire et ceci pour faire un pontage coronarien quand il y a des lésions significatives à côté du geste chirurgical pour la valve aortique On arrive maintenant aux modalités évolutives et les complications de cette maladie Il faut savoir qu'il y a des complications qui sont liées à la sévérité de la valvulopathie, d'autres non En ce qui concerne la première partie on peut avoir un engorgement de repos, une insuffisance ventriculaire gauche, des signes de bas débit cardiaque, voire un choc cardiogénique. Cette maladie peut évoluer vers un anévrysme voire dissection de la horte Rarement on peut voir des signes d'hypertension pulmonaire, d'insuffisance cardiaque globale, fibrillation auriculaire embolie, comme on l'a bien expliqué lors de la physiopathologie Donc les signes de complications non liés à la sévérité de la valvulopathie restent l'endocardite infectieuse car on l'a bien dit la survenue de l'endocardite infectieuse n'est pas liée à la sévérité de la valvulopathie On arrive maintenant aux objectifs du traitement En fait le traitement de l'insuffisance aortique peut avoir 4 objectifs D'abord un traitement curatif c'est à dire guérir la maladie un traitement étiologique c'est à dire chercher et traiter l'étiologie de cette insuffisance aortique Troisième but c'est le traitement des complications et enfin le traitement préventif c'est à dire prévenir la survenue de l'insuffisance aortique En ce qui concerne les moyens dont on dispose il y a le traitement médicamenteux comme les diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour le traitement de l'insuffisance cardiaque le traitement anticoagulant pour traiter les thrombus intra-auriculaire ou intra-oreillette gauche le traitement anti-arythmique comme la digoxine bêta-bloquant pour le traitement des troubles de rythme et à la fin le traitement antibiotique Le traitement chirurgical peut prendre plusieurs aspects le plus important c'est le remplacement valvulaire aortique soit par une valve mécanique soit par une valve biologique d'origine porcine humaine, bovine etc on

peut faire un remplacement de la valve aortique avec l'aorte ascendante ça s'appelle la chirurgie de Benthal on peut faire une plastie aortique et il y a un dernier volet, la chirurgie de Ross qui reste assez spécialisé on ne va pas rentrer dans ces détails mais il est utilisé en général chez la population pédiatrique Les indications de ce traitement il faut savoir que le traitement chirurgical constitue le seul traitement curatif de l'insuffisance aortique l'indication est faite essentiellement quand on fait face à une insuffisance aortique sévère avec un patient symptomatique ou lors de l'apparition de complications comme la dilatation du ventricule gauche la dysfonction ventriculaire gauche ou bien la dilatation de l'aorte ascendante Le choix entre ces différentes méthodes dépend du contexte clinique et paraclinique Le remplacement valvulaire aortique il est réservé aux patients qui ont une insuffisance aortique sans dilatation de l'aorte Le Benthal quand on a une insuffisance aortique sévère avec dilatation de l'aorte Le Ross comme je l'ai dit tout à l'heure il est réservé à l'enfant et à la fin la plastie aortique quand on a une anatomie aortique favorable, chose qui reste rare relativement Le remplacement valvulaire aortique constitue le traitement de choix Le traitement de complications fait appel au traitement médicamenteux les diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour le traitement de l'insuffisance cardiaque la digoxine, bêta bloquant pour le traitement des troubles de rythme les anticoagulants pour prévenir ou bien traiter la survenue d'un thrombus Pour la dilatation du ventricule gauche on peut mettre les patients sous inhibiteurs d'enzyme de conversion Pour la dilatation de l'aorte on met les patients sous bêta bloquant et enfin pour prévenir la survenue de l'endocardite infectieuse on peut avoir recours à l'antibiothérapie Le traitement préventif concerne spécialement la prévention de l'endocardite infectieuse et quand pour l'insuffisance mitrale l'insuffisance aortique est classée dans le groupe A des groupes et le groupe B a un risque moins élevé d'endocardite infectieuse mais dans notre contexte et vu le nombre d'écart qu'on continue à avoir d'endocardite infectieuse chez les patients ayant une insuffisance aortique et chez qui on a trouvé un port d'entrée bico-dentaire donc l'indication de l'antibioprophylaxie avec les soins dentaires reste recommandée chez notre population Donc il s'agit de prescrire de l'amoxycilline 50 mg chez l'enfant ou bien 2 g chez l'adulte une heure avant les soins dentaires La prévention concerne également le rhumatisme articulaire aigu avec le traitement des ongles et mettre les patients sous pénicilline en intramusculaire tous les 21 jours si antécédents de RAA pour prévenir les récurrences Il faut aussi prévenir et traiter les facteurs de risque cardiovasculaire dans les étiologies dégénératives de l'insuffisance aortique et puis traiter les maladies de système et les pathologies rhumatologiques pour éviter l'évolution vers des complications notamment l'insuffisance aortique dans notre cas Donc pour conclure je dirais que l'insuffisance aortique est une pathologie fréquente les étiologies restent diverses dans leur tête la pathologie rhumatismale, dystrophique et dégénérative les complications peuvent être graves dans les formes sévères le traitement chirurgical constitue le traitement de choix et je souligne à la fin l'intérêt de la prévention Vous allez trouver dans les deux plaques suivantes les abréviations utilisées au niveau de ce cours Je vous remercie